

減価通貨による医療費財源の設計

— 実際に政策実装したら、医療システムに何が起きるか —

藤井 佑機（山口大学医学部 6年／株式会社アガティカ 代表取締役）

本資料の位置づけ 本ポスターは「理論（査読前プレプリント）＋部分均衡の会計シミュレーション」です。本資料はその枠組みを政策実装した場合の説明用イメージであり、将来予測・効果の保証ではありません。具体的な数値はシミュレーション本体の出力に限定し、制度設計の構想（玉銀構想）は一つの実装案として示します。



論文（SSRN）はこちら

30秒サマリー：何を解こうとしているか

医療政策の言葉で言うと

課題

医療給付の便益は「健康」という時間とともに失われる資産（高齢者で有効期間 $\approx 4\sim 5$ 年）。一方、財源の通貨・国債は時間が経っても目減りしない。この『給付の時間』と『財源の時間』のズレが、世代間負担と財政持続性の根にある。

提案

医療費財源の一部を「減価通貨（時間とともに価値が減じる通貨）」とし、その減価の速さを健康資本の減耗の速さに合わせる。＝給付と財源の期間を揃える ALM（資産負債の期間整合）を医療財政に適用する。

効果の核

減価率を減耗率に合わせると「自己償還条件 $\mu \cdot M^* = F$ 」が成立。政府が出した通貨が、減価を通じて自動的に医療給付として社会に還元され、新規国債発行への依存を構造的に小さくする。

実装の全体像：円と「機能分離」した第2の通貨

玉銀構想（一つの実装案）：政府ポイント→普及後に法定補完通貨へ段階移行

円を置き換えない。消費のための『減価通貨（仮称：玉）』と、蓄積のための『円』を機能的に分離して共存させる（公理V）。玉は段階的に導入し（当初は政府ポイント、普及後に法定補完通貨）、医療給付の財源の一部に充当する。

① 発行

医療費の（保険料＋公費）の一部 α を玉で発行。受領義務付きの政府ポイント（マイナポイント型）として始め、普及後に法定補完通貨へ移行。決済1玉=1円。

② 流通

個人は月次2%減価＋24ヶ月で消滅、法人は年次20%減価＋5年で消滅（実効寿命 $\approx 4.7 \sim 5$ 年）。法人は最低97%を保証（市場ではほぼ額面どおり換金）。

③ 自己償還

減価分が発行分と会計上釣り合う（ $\mu \cdot M^* = F$ ）。出した玉が医療給付として社会に戻り、国債発行への依存を縮小。

患者・市民に何ができるか

行動の機序（定性）

1

退蔵されない通貨 → 受診の後回しが減る

「貯めても減価する」ため、定期健診・予防医療への支出を心理的に後回しにしにくい。経済的理由による受診手控えを緩和する方向に働く。

2

予防・健康投資の異時点間最適化

減価する玉を健康（健診・運動・栄養）に使うことは『将来の自分への確実な還元』。Grossman 健康資本理論が示す予防投資が促されうる。

3

地域経済の循環

受け取った玉が地域内で次々に使われ、流通速度が上がる（ゲゼルの「自由貨幣」の核心）。地方・過疎地での効果が相対的に大きいと期待。

医療機関に何が起こるか

現場のオペレーションと臨床の変化

■ 経営・オペレーション

運用

診療報酬の一部を玉で受領。決済は1:1。法人は円交換市場でほぼ額面どおり換金でき、最低97%を政府保証して下値を固める。アプリが自動処理し現場の手間は小。

資金繰り

玉は減価するため早期の支出・円交換が合理的。退職されず運転資金として循環。

■ 臨床・公衆衛生

臨床

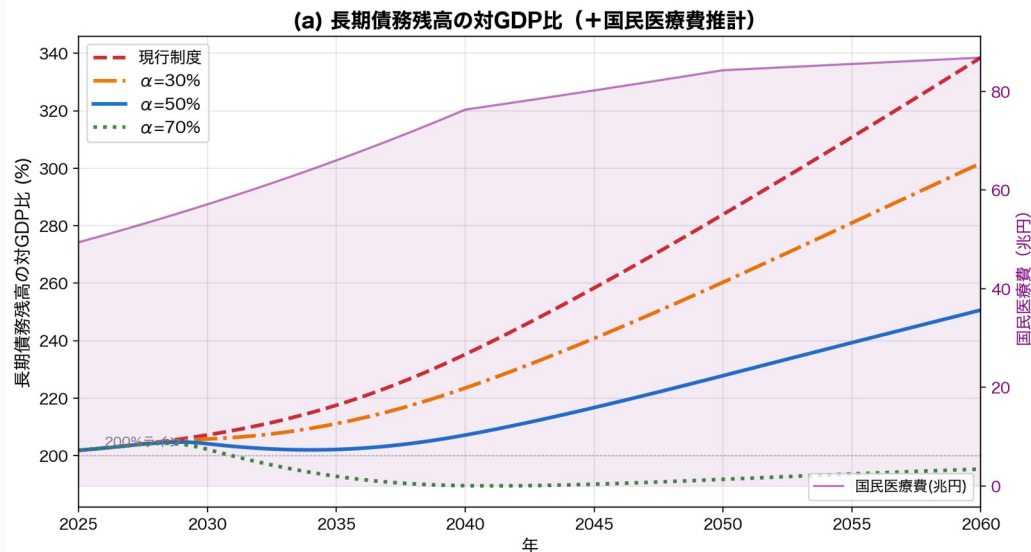
予防・早期受診が増えることで、慢性疾患の管理が早期化し、救急・重症化症例が緩やかに減少しうる。

公衆衛生

保健活動・予防接種・健診の受診率上昇が期待され、健康寿命の延伸につながりうる。

政府財政に何が起こるか

本ポスターのシミュレーション（権威値）



2060年の見通し（医療費財源の70%を玉に置換）

長期債務/GDP

338.5% → 195.3%

▲143pt

健康保険料率

10% → 8.0%

フロア達成

物価上昇率

2.02% → 最大2.50%

+0.48pt（日銀M2調整で相殺可）

※ simulation_v10.py（部分均衡の会計モデル、exact-year 2060断面）。後ろ向き検証では $\alpha=50\%$ で実績204.8→175.8%（▲29pt）。行動変化・一般均衡は射程外。

段階的実装ロードマップ（イメージ）

政府ポイント先行で着手し、普及後に法定補完通貨へ移行する段階的プロセス

STEP 1 政府ポイントで着手

受領義務付きの政府ポイント（マイナポイント型）として既存の決済基盤で発行開始。減価率・消滅期限・円交換の運用を実地で固める。

STEP 2 医療現場で普及拡大

診療報酬の一部をポイントとして配布し医療現場・地域で利用を拡大。アプリ・台帳・3層価格（決済1:1／法人保証97％／市場）を実地で検証。

STEP 3 法定補完通貨へ移行

普及・受容を踏まえ法制化し法定補完通貨へ移行（法的地位を確立）。充当率 α を段階的に引上げ、保険料率フロア（8％）を保ち公費・国債依存を縮小。

STEP 4 効果検証と恒久化

債務動態・受診行動・健康指標をモニタリング。 δ の実証推定（DPC等）と並行し、法定補完通貨として恒久制度に定着。

参考：医療財源を超えた拡張可能性

玉銀構想の「3レバー」（本ポスターの射程外）

同じ『減価通貨×時間設計』の枠組みは、医療財源以外にも応用が構想されている。これらは本ポスター（医療財政）の射程外であり、将来の研究・政策論として提示する。

レバー1：子育て支援

減価通貨での子供手当。将来の不確実性を『現在の確実な購買力』に変換し、出産・育児の意思決定を後押しする狙い。

レバー2：人材・成長

高度人材への減価通貨給与など、人口減少・高齢化への構造的応答。即時の生活安定を訴求。

レバー3：予防医療投資

健康寿命延伸への投資として、 δ - μ マッチング原理を本来の意味で実装。医療財政と健康政策の統合。

留意点・射程と、さらに知りたい方へ

- 本ポスターは『理論（査読前プレプリント）＋部分均衡の会計シミュレーション』。本資料の実装像は説明用イメージであり、将来予測ではない。
- 減価による実質負担が最終的に誰に帰着するか（リカード等価性の成否を含む）の一般均衡分析は本枠組みの射程外で、続編論文（welfare incidence 編）に委ねる。
- δ （健康資本減耗率）の精密な実証推定は DPC 等を用いた今後の中心課題。本資料の数値は仮定下のシミュレーション出力。
- インフレへの影響は仮定依存が強い（地域通貨経験則に基づく）。日銀が M2 成長を抑制すれば 2% に完全オフセット可能（感度分析で頑健性を確認）。



論文（SSRN）

利益相反（COI）開示： 筆頭演者は株式会社アガティカ（医療機関向けキャッシュレス決済アプリ開発）の代表取締役を兼務。本研究に外部資金は使用していない。 AI利用開示： 翻訳・文章整形・作図の補助に Claude（Anthropic）・ChatGPT（OpenAI）を使用（ICMJE/COPE準拠）。 連絡先： ainsoph567@gmail.com／ORCID 0009-0000-0981-2417